

ABCDE DEL MALORE

Anticipazione

- Verifica dei materiali:
- Distribuzione di compiti e ruoli
- Distribuzione del materiale da portare (zaino, aspiratore, O2, DAE).

QUICK LOOK

- accessibilità
- vitalità
- cute
- emorragie
- aiuti

A – AIRWAY

- valutazione della coscienza
- pervietà delle vie aeree
- **Alert:**
 - paziente incosciente.
 - compromissione in atto delle vie aeree
 - grave rischio di ostruzione delle vie aeree

B – BREATHING

- **O**sserva il carattere del respiro (normale, difficoltoso, ecc.)
 - espansione della gabbia toracica (simmetrica, asimmetrica)
 - utilizzo di eventuale muscolatura accessoria.
 - presenza di rumori respiratori.
- **P**alpa, se necessario, la gabbia toracica alla ricerca di lesioni o dolore alla palpazione.
- **C**onta frequenza respiratoria.
- **S**aturazione: rileva SpO2
- **Alert:**
 - dispnea
 - FR >30 o <10 atti/minuto;
 - saturazione < 90% per chiedere la possibilità di somministrare O2

C – CIRCULATION (CIRCOLAZIONE)

- Presenza del polso, valutare ritmicità e frequenza
- Rilevare pressione arteriosa
- Valutare colorito cutaneo
- Valutare sudorazione
- Indice di shock
- **Alert:**
 - Polso radiale assente
 - FC <50 o >120 battiti/minuto
 - PAS < 100 mmHg

D – DISABILITY (DISABILITÀ) - Valutazione dello stato neurologico

- Scala SVDN
- Sensibilità e motilità toccando o pizzicando uno alla volta i 4 arti e chiedendo di muoverli
- GFAST con annotazione dell'ultima volta che il paziente è stato visto privo di sintomatologia e il numero di telefono di un parente.
- **Alert:**
 - mancata risposta allo stimolo verbale (livello D o N della scala SVDN)
 - scala di GFAST positiva

E – ESPOSIZIONE

- Raccolta dati - AMPIA:
 - **A**llergie
 - **M**edicinali
 - **P**atologie (diabete, ipertensione, epilessia, problemi cardiovascolari)
 - **I**ngerito ultimo pasto (quando?)
 - **A**ltro
- Gestione del dolore. Scala 0 -> 10 del dolore
- Comunicazione con la COP (esito delle valutazioni e parametri vitali)

ABCDE TRAUMA - POLITRAUMATIZZATO

Si definisce politraumatizzato un soggetto con lesioni a carico di due o più distretti corporei sufficientemente gravi da compromettere (realmente o potenzialmente) una o più funzioni vitali.

Anticipazione

- Verifica dei materiali:
- Distribuzione di compiti e ruoli
- Distribuzione del materiale da portare (zaino, aspiratore, O2, DAE).

QUICK LOOK

- accessibilità
- vitalità
- cute
- emorragie
- aiuti

A – AIRWAY E RACHIDE CERVICALE

- valutazione della coscienza
- pervietà delle vie aeree
- immobilizzazione del capo
- posizionamento del collare
- ossigeno (12/15 litri/minuto con reservoir)
- **Alert:**
 - paziente incosciente.
 - compromissione in atto delle vie aeree
 - grave rischio di ostruzione delle vie aeree
 - controindicazioni all'immobilizzazione del rachide cervicale
 - paziente agitato

B – BREATHING

- **O**sserva il carattere del respiro (normale, difficoltoso, ecc.)
 - espansione della gabbia toracica (simmetrica, asimmetrica)
 - utilizzo di eventuale muscolatura accessoria.
 - presenza di rumori respiratori.
- **P**alpa, se necessario, la gabbia toracica alla ricerca di lesioni o dolore alla palpazione.
- **C**onta frequenza respiratoria.
- **S**aturazione: rileva SpO2
- **Alert:**
 - dispnea
 - FR > 30 o < 10 atti/minuto;
 - saturazione < 90% per chiedere la possibilità di somministrare O2

C – CIRCULATION (CIRCOLAZIONE)

- Trattamento di eventuali emorragie
- Presenza del polso, valutare ritmicità e frequenza
- Rilevare pressione arteriosa
- Valutare colorito cutaneo
- Valutare sudorazione
- Indice di shock
- **Alert:**
 - emorragie incontrollabili
 - posizionamento di laccio emostatico
 - Polso radiale assente
 - FC <50 o >120 battiti/minuto
 - PAS < 100 mmH

D – DISABILITY (DISABILITÀ) - Valutazione dello stato neurologico

- Scala SVDN
- **Alert:**
 - mancata risposta allo stimolo verbale (livello D o N della scala SVDN)
 - scala di GFAST positiva

E – ESPOSIZIONE (Valutazione testa piedi)

- Valutazione testa piedi alla ricerca di
 - contusioni
 - ferite ed emorragie non individuati
 - ustioni
 - deformità
 - limitazioni funzionali degli arti
 - deficit di sensibilità o motilità
 - dolore
- Protezione termica
- Dinamica dell'evento. Gli eventi di dinamica maggiore sono :
 - caduta da oltre 3 m di altezza (o comunque da più della propria altezza nel paziente di età <14 anni o >65 anni)
 - eiezione dal veicolo
 - proiezione a distanza (>2 metri)
 - tempi di estricazione prolungati (>20 min)
 - grave deformità del veicolo
 - presenza di persone decedute nel veicolo
 - arrotondamento o schiacciamento da parte del veicolo
 - deformazione e/o mancanza del casco protettivo
 - età inferiore a 5 anni
- Raccolta dati - AMPIA:
 - **A**llergie
 - **M**edicinali
 - **P**atologie (diabete, ipertensione, epilessia, problemi cardiovascolari)
 - **I**ngerito ultimo pasto (quando?)
 - **A**ltro
- Gestione del dolore. Scala 0 -> 10 del dolore
- Comunicazione con la COP (esito delle valutazioni e parametri vitali)
- **Alert:**
 - otorragia con alterazione stato di coscienza
 - addome o bacino dolente con deformità o tumefazione
 - amputazioni parziale o completa di estremità
 - sospetta frattura di almeno due segmenti ossei prossimali (deformità con limitazione motoria)
 - deficit di sensibilità e motilità
 - trauma e/o ferita da esplosione
 - ustione di II o III grado >18% della superficie corporea o del volto (rischio ostruzione vie aeree)
 - necessità di analgesia
 - criteri di dinamica maggiore